

Pasos a seguir en Reanimación cardiopulmonar en bebés de hasta 1 año de vida

Ante una sospecha de que algo le ocurre a un bebé, porque lo nota inconsciente o ve un cambio de coloración en su piel, boca o labios; acercarse y realice dos estímulos:

1 Estímulo Físico: palmada en la planta de los pies- Estímulo Auditivo: eleve la voz

2

¿Responde a los estímulos?

SI

Implica que la persona se mueve, llora.

NO

Implica que la persona no se mueve, no reacciona

3

PIDA AYUDA

Grite energicamente y llame al sistema de emergencia médica (ej.: 107 SAME)

4

VERIFIQUE QUE LA PERSONA NO RESPIRA

Observe el tórax y el abdomen para visualizar movimientos.
Mire al menos 5 segundos pero no más de 10 (como los dedos de la manos)

5

¿Respira?

SI

Si respira su corazón funciona, espere la ambulancia.

NO

Si **NO RESPIRA** su corazón no está funcionando o dejará de funcionar.

6

POSICIÓN PARA REALIZAR RCP

Con la persona **boca arriba** y sobre **superficie dura**, **descubre el pecho** y **coloque los dedos** índice y mayor, **talón de la mano** (un reanimador) ó dos pulgares (si son dos reanimadores) en el centro del pecho.

Sobre el hueso esternón y apenas por debajo de la línea de las tetillas}

7

CRITERIOS DE COMPRESIONES EFECTIVAS

- Frecuencia : **100 a 120** por min.
- Profundo : **4 cm o 1/3** altura tórax
- Permitir que el **tórax se eleve** (re expansión)
- **Combinar 30 compresiones con 2 Respiraciones**

Realice 30 compresiones antes de iniciar las respiraciones

8

REALICE 2 INTENTOS DE RESPIRACIONES

- **Tape la nariz**
- Con la otra mano apoye los **dedos en el mentón** y busque **posición** de la cabeza (posición intermedia- posición de olfateo)
- Tome aire nuevo (cargue sus pulmones)
- Acérquese, **apoye la boca herméticamente** y **mire el tórax**
- **Entregue el aire** hasta ver que el tórax se mueve y deje de soplar (la respiración debe durar 1 segundo aproximadamente)
- **Despegue su boca de la boca del bebé** y levante su cabeza.
- Tome nuevamente aire y repita por segunda vez la técnica.

9

RETOME LAS COMPRESIONES

- Realice **30 compresiones** y combine con las respiraciones de manera continua hasta que la persona responda , salga del evento (se mueva, respire, llore)
- Minimice los tiempos en los que deja de realizar compresiones

10

Si salió del evento la persona moverá por su propia cuenta alguna parte del cuerpo (respirar es considerado moverse)
Espere a la ambulancia en el lugar que se encuentre.

Maniobra de desobstrucción en bebés hasta 1 año por obstrucción severa de la vía aérea

1 Ante una persona que no puede emitir sonido y que estuvo ingresando algo a la boca (comida, objetos pequeños) sospeche de que está ante un evento de obstrucción severa de la vía aérea

SI

Entonces no es una obstrucción severa

2 ¿La persona puede emitir sonidos o toser?

NO

Sospeche que es una obstrucción severa

3

- Tome al bebé con los dos brazos y llévelo sobre una pierna posicionándolo boca abajo
- De 5 golpes entre los omóplatos/escápulas (espalda zona alta)
- Gire y lleve al bebé hacia la otra pierna
- Realice 5 compresiones torácicas
- Observe si en la boca hay un objeto, si lo ve intente retirarlo, si NO lo ve, no ingrese los dedos en la boca a ciegas.
- Repite la técnica siempre y cuando la persona no pierda el conocimiento

4

SI

La persona debe ser valorada por personal de salud

¿Pudo resolver la obstrucción?

NO

Estará ante una persona que No Responde, No Respira. Pida ayuda, posicione a la persona en una superficie dura e inicie maniobras de RCP iniciando con las compresiones

5

POSICIONARSE PARA REALIZAR RCP

Con la persona boca arriba y sobre superficie dura, descubra el pecho y coloque los dedos índice y mayor (si hay un reanimador), dos pulgares (si son dos reanimadores) en el centro del pecho

Sobre el hueso esternón y apenas por debajo de la línea de las tetillas

6

REALIZAR 2 INTENTOS DE RESPIRACIONES

- Tape la nariz
- Con la otra mano apoye los dedos en el mentón y busque posición de la cabeza (posición intermedia- posición de olfateo)
- Tome aire fresco (cargue sus pulmones)
- Acérquese, apoye la boca herméticamente y mire el tórax
- Entregue el aire hasta ver que el tórax se mueve y deje de soplar (la respiración debe durar 1 segundo aproximadamente)
- Despéguese de la boca y levante su cabeza.
- Tome nuevamente aire y repita por segunda vez la técnica.

7

RETOME LAS COMPRESIONES

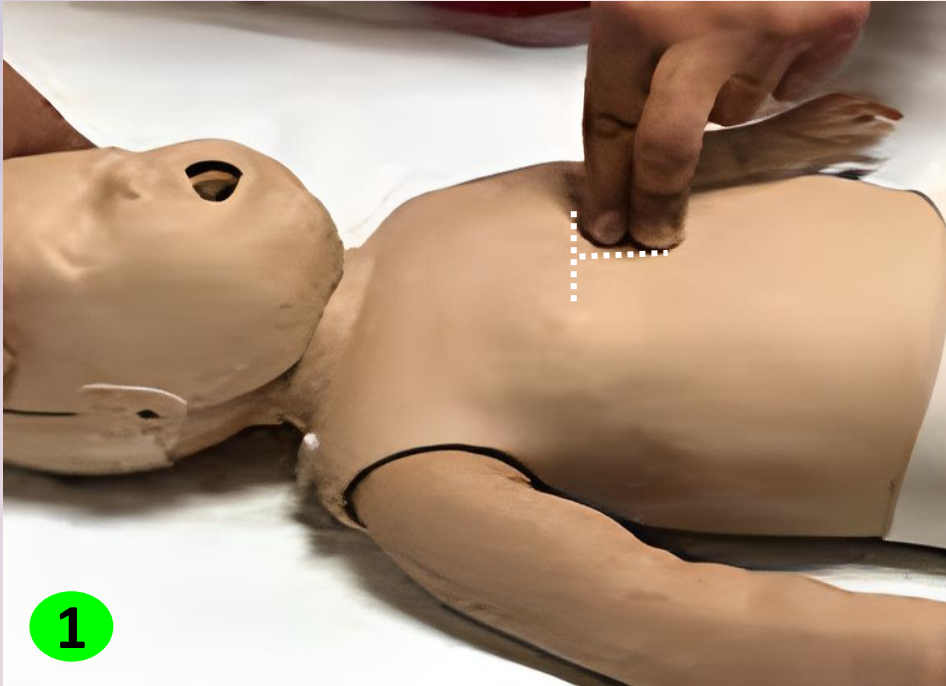
- Realice 30 compresiones y combine con las respiraciones de manera continua hasta que la persona responda, salga del evento (se mueva, respire, llore)
- Minimice los tiempos en los que deja de realizar compresiones

8

Si salió del evento la persona moverá por su propia cuenta alguna parte del cuerpo (respirar es considerado moverse)
Esperar a la ambulancia en el lugar que se encuentre.

Posición de las manos en Reanimación en bebés de hasta 1 año de vida

Apoye la punta yema de los dedos en el centro del pecho sobre el hueso esternón apenas debajo de la línea imaginaria trazada entre las tetillas



1
Recomendado cuando hay un solo operador.



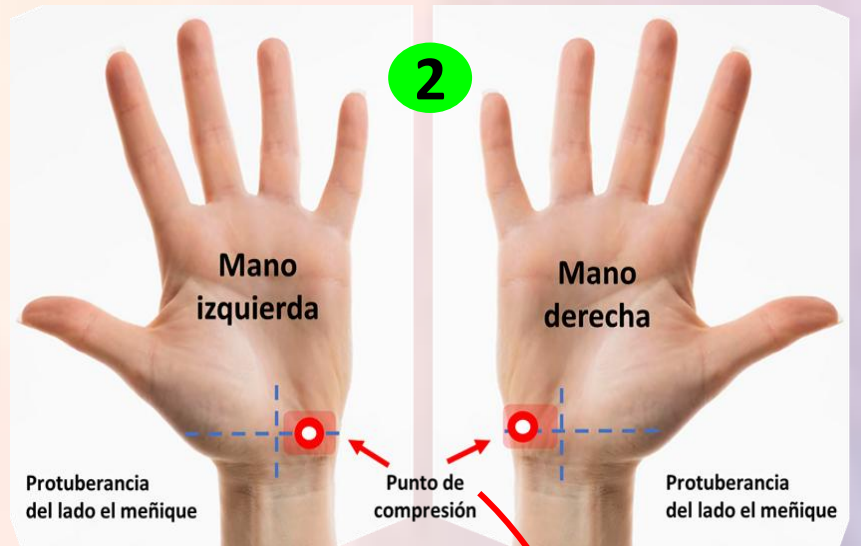
2
Recomendado cuando hay mas de un operador.



SANATORIO MATER DEI
HERMANAS DE MARÍA DE SCHÖNSTATT

Técnica con el talón de las manos en Reanimación en bebés de hasta 1 año de vida

Apoye el talón de la mano con la protuberancia del lado del meñique para mayor comodidad y focalización del punto de compresión.



- Identificar el talón de la mano.
- Diferenciar las protuberancias del talón de la mano.
- Hacer coincidir el la protuberancia del lado del meñique para que coincida con el punto de apoyo de referencia: Sobre el esternón apenas por debajo de la línea de las tetillas e inicie las compresiones.



Imágenes de maniobra de desobstrucción de la vía aérea en bebés hasta 1 año por obstrucción severa

Inicie con la maniobra si la persona no puede emitir sonido y estando consciente.



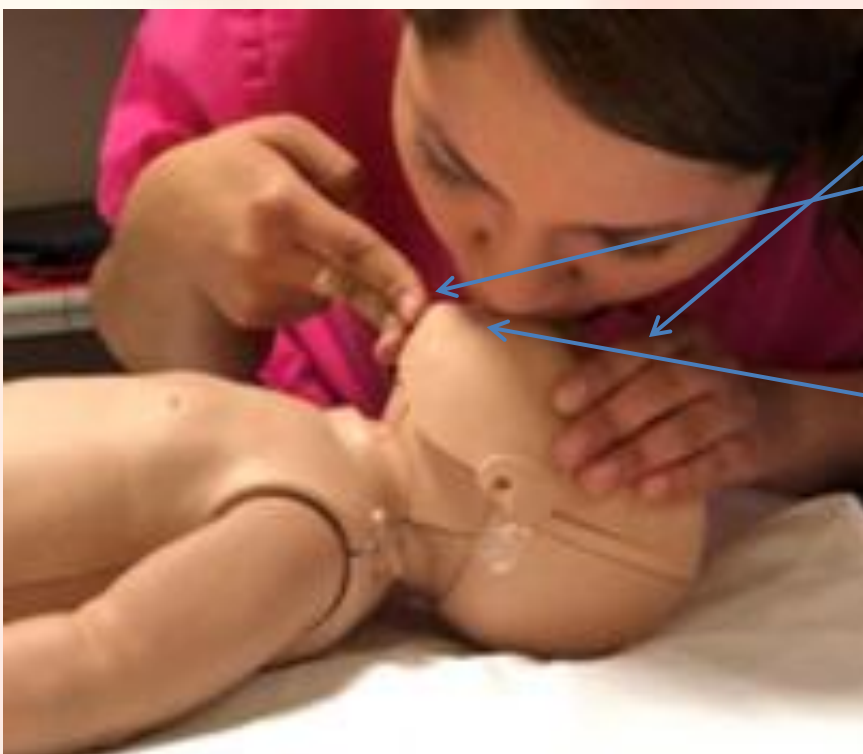
Dé vuelta al bebé, apoye sobre su a pierna y pié bien apoyados, dar hasta 5 golpes secos con el talón de la mano en la espalda alta, entre las escápulas

Dé vuelta al bebé y comprimir hasta 5 veces el tórax de la misma manera que se aplica de la técnica de RCP, luego gire al bebé iniciando la técnica nuevamente.

- NO introducir los dedos en la boca si no ve el objeto.
- Si el bebé pierde la consciencia iniciar con secuencia de RCP.
- Toda persona a la que se le realiza la maniobra debe ser evaluado por un personal de salud

Imagen de maniobra de técnica de respiración boca a boca en bebés hasta 1 año de vida

Iniciar con la maniobra luego de haber realizado 30 compresiones



- 1** Tape la nariz
- 2** Lleve los dedos en el mentón y busque la posición Intermedia (posición de olfateo)
- 3** Tome aire fresco
- 4** Apoye los labios herméticamente y entregue el aire manteniendo la posición y soplando hasta ver que se mueva el tórax
- 5** Realice dos intentos y retome a realizar los masajes cardíaco

- La entrega de aire debe ser de 1 segundo de duración aproximadamente
- Mantenga la posición de la cabeza al dar la respiración, no hiper-extienda ni deje la cabeza en posición neutra.
- Lleve la cabeza hacia atrás utilizando los dedos apoyados en el mentón